

ID Paciente: P003

NHC: NHC-2020-007162

Generado: 09/04/2026

HISTORIA CLÍNICA INTEGRADA

1. Datos del paciente

Nombre completo	Rosa María Beltrán Ortiz
Sexo	Mujer
Fecha de nacimiento	03/11/1945 (79 años)
DNI	18.654.029-M
Teléfono	964 321 100
Municipio	Vila-real
Médico responsable	Dra. Ana García Peris
Especialidad	Nefrología

2. Antecedentes personales

- Enfermedad renal crónica estadio G3b A3 (eGFR 32 mL/min/1,73m²)
- Diabetes mellitus tipo 2 (diagnóstico 2005)
- Hipertensión arterial resistente en tratamiento triple
- Anemia crónica de enfermedad renal (Hb basal 10,2 g/dL)
- Osteoporosis en tratamiento con alendronato
- Depresión mayor en remisión — seguimiento psiquiatría
- Alergia a sulfamidas (urticaria documentada 1998)

Antecedentes familiares: No historia familiar de nefropatía hereditaria conocida.

3. Historia clínica

Paciente de 79 años con ERC estadio G3b A3 en seguimiento estrecho por nefrología. La nefropatía tiene origen diabético e hipertensivo. En los últimos 6 meses se ha observado descenso progresivo del FGe de 38 a 32 mL/min/1,73m². Refiere cansancio marcado, disnea de esfuerzo a medianos esfuerzos y edemas vespertinos en ambos tobillos. Sin hematuria macroscópica. Diuresis conservada. Dieta hipopotasémica e hiposódica con buena adherencia declarada. Se ajustó dosis de metformina (suspendida desde FGe < 45) y se añadió eritropoyetina subcutánea hace 4 meses con respuesta parcial.

4. Exploración física

Peso / Talla / IMC	71 kg · 158 cm · 28,4 kg/m ² (aumento 2 kg en 1 mes)
Tensión arterial	158/94 mmHg (media 3 tomas brazo derecho)
Frecuencia cardíaca	82 lpm, rítmica
Temperatura	36,3 °C

Saturación O2	95 % (aire ambiente)
Auscultación cardiaca	Tonos rítmicos. No soplos
Auscultación pulmonar	Crepitantes basales bilaterales finos
Abdomen	Sin ascitis. Riñones no palpables
MMII	Edemas con fóvea ++ bilateral hasta rodilla. Pulsos presentes

■ 5. Tratamiento farmacológico actual

Medicamento	Posología
Insulina glargina 20 UI	Subcutánea en la noche
Repaglinida 1 mg	1 comp. antes de las 3 comidas principales
Amlodipino 10 mg	1 comp. en desayuno
Losartán 100 mg	1 comp. en desayuno (protección renal)
Furosemida 40 mg	1 comp. en desayuno
Carvedilol 12,5 mg	1 comp. cada 12 h
Eritropoyetina beta 4.000 UI	Subcutánea 3 veces/semana
Carbonato cálcico + Vit D3	1 comp. con comidas
Alendronato 70 mg	1 comp. semanal (lunes en ayunas)
Sertralina 50 mg	1 comp. en desayuno

■ 6. Nota de seguimiento — 10/03/2025

Motivo de consulta	Control mensual nefrología — deterioro progresivo FGe
--------------------	---

Subjetivo (anamnesis):

La paciente acude con su hijo. Refiere aumento del cansancio respecto a visita previa. Ortopnea de 2 almohadas esta semana. Edemas que han aumentado desde hace 10 días. Ingesta de líquidos controlada. Cumplimiento correcto de la medicación. Dieta: refiere haber consumido conservas con alto contenido en sal la semana pasada por error.

Objetivo (datos clínicos):

FGe 32 mL/min/1,73m² (previo 36 hace 2 meses). Proteinuria 1,8 g/24h. Hb 9,8 g/dL. TA 158/94 mmHg. Peso aumentado 2 kg en 1 mes. Potasio 5,6 mEq/L.

Plan terapéutico:

- Aumentar furosemida a 80 mg/día ante signos de sobrecarga hídrica.
- Restricción hídrica estricta: 1.200 mL/día. Reforzar educación dietética (sodio < 2 g/día).
- Hiperpotasemia: revisar losartán. Añadir patirómero 8,4 g/día si K > 5,5 mEq/L en control.
- Aumentar dosis eritropoyetina a 6.000 UI x 3/semana. Control Hb en 4 semanas.
- Informar a paciente y familia sobre estadio avanzado de ERC y posibilidad de preparación para terapia sustitutiva renal (diálisis/trasplante) si progresión.
- Próxima revisión en 4 semanas con analítica urgente (FGe, K, Hb).

■ 7. Resultados de laboratorio — 08/03/2025

Parámetro	Resultado	Referencia	Flag	Unidades
Creatinina	2,14	0,50 – 1,10	H	mg/dL
Urea	98	10 – 50	H	mg/dL
FGe (CKD-EPI)	32	≥ 60	H	mL/min/1,73m ²
Proteinuria 24h	1,8	< 0,15	H	g/24h
HbA1c	7,4	< 8,0 (ERC)	N	%
Glucosa basal	128	70 – 130	N	mg/dL
Hemoglobina	9,8	12,0 – 16,0	H	g/dL
Hierro sérico	52	60 – 170	L	mcg/dL
Ferritina	38	12 – 150	N	ng/mL
K (Potasio)	5,6	3,5 – 5,0	H	mEq/L
Na (Sodio)	137	136 – 145	N	mEq/L
Fósforo	5,2	2,5 – 4,5	H	mg/dL
PTH intacta	198	15 – 65	H	pg/mL
Bicarbonato	19	22 – 29	L	mEq/L

Observaciones: ERC G3b A3 con deterioro progresivo. Hiperpotasemia moderada (5,6 mEq/L) y acidosis metabólica leve (bicarbonato 19 mEq/L). Hiperfosfatemia e hiperparatiroidismo secundario compatibles con MO-ERC. Anemia ferropénica relativa superpuesta a anemia de ERC. Se recomienda añadir suplemento de hierro oral y bicarbonato sódico 500 mg c/8h.

Documento de uso exclusivo para investigación. Todos los datos son ficticios. Generado para el TFG: Sistema RAG de información biomédica y clínica.